



上皮性腫瘍：良性

epithelial tumors : benign tumor

到達目標

- 代表的な肺良性上皮性腫瘍の種類と発生部位が説明できる
- 臨床像、画像所見、治療法が説明できる
- その他の腫瘍性病変との鑑別ができる

定義・病態・疫学

良性腫瘍とは、発育速度が緩徐で、膨張性に増殖し、浸潤・転移をきたさない腫瘍性病変である。肺の良性腫瘍を構成する細胞は、正常の気管・気管支や肺組織に認められる、扁平上皮細胞、線毛円柱上皮細胞、漿液粘液腺・導管上皮細胞、肺胞上皮細胞に由来する。主に乳頭腫と腺腫があり、それぞれにいくつかのサブタイプがある。

a 乳頭腫^{1,2)}

扁平上皮乳頭腫、腺上皮乳頭腫、扁平上皮腺上皮混合型乳頭腫の3つの亜型がある。最も頻度が高いのは扁平上皮乳頭腫だが、肺の腫瘍性病変の中でも1%未満とまれで、ヒトパピローマウイルス（human papillomavirus : HPV）感染の関与も一部に示唆されている。また扁平上皮乳頭腫と扁平上皮腺上皮混合型乳頭腫においては、扁平上皮癌への悪性化の報告がある。

b 腺腫^{1,2)}

硬化性肺胞上皮腫、肺胞腺腫、乳頭腺腫、粘液嚢胞腺腫、粘液腺腺腫がある。代表的なものは、硬化性肺胞上皮腫である。以前は硬化性血管腫と呼ばれていたが、これらの構成細胞が肺胞上皮由来であることが明らかとなったために、硬化性肺胞上皮腫と名称変更となった。中年女性に多くみられ、男女比は1:4で、人種別では東アジアに多い。また他の腺腫病変は極めてまれである。

症候・身体所見

乳頭腫は中枢気管支内に発生することが多く、咳嗽や喘鳴などの気道閉塞症状や発熱、血痰などが出現する。末梢細気管支内に発生することもあるが、その場合は大体が無症状である。腺腫はほとんどが末梢肺組織に発生するため、無症状なことが多い。粘液腺腺腫に限っては中枢側に発生するため、乳頭腫と同様に気道閉塞様症状を呈する。

診断・検査

無症状の頻度も高いことから、胸部画像検査で偶発的にみつかることが多い。CT検査で、乳頭腫は気管支内ポリープ様病変、結節影、腫瘤影、air-trappingを伴った気道壁の肥厚、無気肺、consolidationなどさまざまな所見を呈し、腺腫はほとんどが孤立性の末梢結節影、腫瘤影を呈する。PET検査ではFDGの集積を示すことがあるとの報告もあり、その場合、悪性腫瘍、クリプトコックスや抗酸菌症などの感染症が鑑別となる。

確定診断は生検、外科的切除による組織学的検査である。しかし末梢の小さな孤立性結節の場合は生検自体が困難なこともあり、診断的に外科的切除を選択することもある。

治療と予後

中枢気管支に局限した乳頭腫では気管支内視鏡的切除やレーザー治療³⁾、または外科的切除が行われている。内視鏡的治療による気道穿孔のリスクや局所再発、悪性化の可能性から外科的切除が選択されることもある。末梢病変においては、CT画像で良性が示唆される場合は経過観察することもあるが、CT画像で良悪鑑別困難、FDG-PET集積性があり、生検することも困難であった場合は、外科的切除を選択する。単発性の病変であれば予後は良好で、完全切除されれば再発はない。

Advanced

■再発性呼吸器乳頭腫症

HPV感染に起因する再発性呼吸器乳頭腫症は、咽頭から肺にかけて広範に乳頭腫が多発・再発する稀少な疾患で、その発症は全年齢層にわたる。HPV6型または11型の感染が関与していると報告があり、HPVワクチン接種により長期的な再発予防効果が示唆されている。

文 献

- 1) Travis WD, et al : WHO classification of Tumors of the Lung, Pleura, Thymus and Heart, 5th Ed, IARC, 2021
- 2) 日本肺癌学会（編）：臨床・病理 肺癌取扱い規約，第9版，金原出版，2025
- 3) Kajiwaru N, et al : J Thorac Dis 3 : 10, 2011